

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Oxitocina Generis 10 U.I./1 ml solução injetável

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada ampola de 1 ml de Oxitocina Generis contém 0,01667 mg de oxitocina como substância ativa, correspondente a uma atividade biológica de 10 U.I./ml.

Excipiente(s) com efeito conhecido

Cada ampola de 1 ml de Oxitocina Generis contém 2,43 mg (0,11 mmol) de sódio.

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução injetável.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Indução do trabalho de parto, no final do tempo de gravidez.

Estimulação da contractilidade em casos de inércia uterina primária ou secundária.

Controlo da hemorragia pós-parto, em mulheres nas quais os derivados da cravagem do cotejo não estão indicados.

4.2 Posologia e modo de administração

A oxitocina deve ser utilizada exclusivamente em meio hospitalar e sob controlo médico.

Para indução do trabalho de parto, a administração faz-se sempre por perfusão intravenosa e nunca por via intramuscular. O controlo adequado da velocidade de perfusão é essencial e deve utilizar-se uma bomba de perfusão ou outro equipamento semelhante.

A doente deve estar constantemente vigiada por pessoal especializado na utilização deste medicamento e nas possíveis complicações do tratamento.

Posologia

Indução do trabalho de parto ou estimulação da contractilidade uterina

Utiliza-se sempre a perfusão intravenosa. Iniciar a perfusão com uma solução sem oxitocina, preferencialmente soro fisiológico

Preparar a solução de oxitocina dissolvendo de forma asséptica uma ampola de 10 U.I. em 1000 ml de solvente não hidratante. Agitar suavemente ou rodar o frasco ou o saco várias vezes antes da utilização para garantir uma mistura homogênea (a solução contém 10 mU/ml de oxitocina).

Colocar a solução no sistema de perfusão. A dose inicial não deve ser superior a 1-2 mU/min. (2 a 4 gotas/min., caso não haja equipamento adequado para efetuar a medição) e deve aumentar-se gradualmente em 1-2 mU/min. (2 a 4 gotas/min.) até que as contrações sejam semelhantes às do trabalho de parto normal. A dose máxima recomendada é de 20 mU/min. (40 gotas/min.).

A dose deve sempre ser ajustada à resposta individual. Para isso, a doente deve ser cuidadosamente vigiada (frequência cardíaca fetal, pressão sanguínea; se possível tocometria). Em caso de ocorrência de um estado de hiperatividade uterina e/ou sofrimento fetal deve imediatamente interromper-se a perfusão e administrar oxigénio à mãe.

Hemorragia pós-parto

Dissolver entre 10 e 40 U.I. de oxitocina (1 a 4 ampolas) em 1000 ml de solvente não hidratante e manter a perfusão à velocidade necessária para controlar a atonia uterina.

População pediátrica

Oxitocina Generis não está indicada em crianças.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

Desproporção cefalopélvica, apresentação anormal, toxemia severa, predisposição a embolia por líquido amniótico (morte do feto no útero, desprendimento prematuro da placenta). Historial de cesariana ou qualquer outro ato cirúrgico afetando o útero, placenta prévia, contrações hipertónicas, distocias mecânicas, sofrimento fetal quando o parto não é iminente.

Oxitocina Generis não deve ser administrado conjuntamente com prostaglandinas ou outros estimulantes das contrações uterinas e nunca num intervalo inferior a seis horas após a administração destas.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

A indução do trabalho de parto com oxitocina só deve ser feita por razões médicas e nunca por conveniência.

O médico deverá avaliar cuidadosamente o benefício da utilização de oxitocina nas seguintes condições: parto prematuro, partos múltiplos, distensão excessiva do útero, em múltiparas de idade superior a 35 anos ou a partir do quinto parto. Deve reduzir-se o

volume de perfusão em doentes com transtornos cardiovasculares. Devem utilizar-se soluções mais concentradas ajustando devidamente a dose.

Deve ter-se em consideração que mesmo em casos de utilização correta da oxitocina e supervisão adequada, podem verificar-se contrações hipertónicas em doentes hipersensíveis à oxitocina.

A indução farmacológica do parto com dinoprostona ou oxitocina está associada a um risco acrescido de coagulação intravascular disseminada (CID) pós-parto, considerada uma situação muito rara. Este risco acrescido pode ser ainda mais relevante se a idade da mulher for igual ou superior a 35 anos, se ocorrerem complicações durante a gravidez e se a idade gestacional for superior às 40 semanas. Nestas mulheres, a utilização de Oxitocina Generis deverá ser efetuada com especial atenção e os profissionais de saúde deverão estar atentos a qualquer sinal de CID (i.e. fibrinólise).

Anafilaxia em mulheres com alergia ao látex

Foram reportados casos de anafilaxia na sequência da administração de oxitocina em mulheres com alergia conhecida ao látex. Devido à homologia estrutural existente entre a oxitocina e o látex, a alergia/intolerância ao látex pode ser um fator de predisposição de risco importante para a anafilaxia pós-administração de oxitocina.

Oxitocina Generis contém sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Os anestésicos gerais com grande poder relaxante do útero (halotano, clorofórmio, etc.) podem antagonizar o efeito da oxitocina.

A administração com agentes vasopressores pode originar hipertensão arterial severa durante o período pós-parto. Encontram-se descritos alguns casos de acidente vascular por este motivo.

Está contraindicado o uso concomitante de Oxitocina Generis com prostaglandinas ou outros estimulantes das contrações uterinas (ver secção 4.3).

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Não aplicável. Ver secção 4.1.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não se encontram disponíveis dados sobre os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

Podem surgir, por vezes, com as doses recomendadas, quadros de hiperatividade uterina (hipertonicidade, espasmos, contrações tetânicas, rutura do útero) devidas a

hipersensibilidade. No entanto, a maioria destes casos acontece com a utilização de doses excessivas.

A oxitocina tem um ligeiro efeito antidiurético. A administração durante longos períodos pode resultar numa intoxicação hídrica, especialmente se a doente receber simultaneamente líquidos por via oral (ver secção 4.9).

São descritos outros efeitos indesejáveis: bradicardia fetal, icterícia neonatal, reações anafiláticas, hemorragia pós-parto, arritmias cardíacas, contrações ventriculares prematuras, náuseas, vômitos, hematoma pélvico, afibrinogenemia.

Descreveu-se um aumento do risco de coagulação intravascular disseminada após o parto em doentes submetidas a indução farmacológica do parto com dinoprostona ou oxitocina (ver secção 4.4). A frequência destas reações adversas parece ser, no entanto, rara (< 1 em cada 1000 partos).

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram> (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

A sintomatologia do quadro de intoxicação hídrica inclui dores de cabeça, náuseas, vômitos, anorexia e dor abdominal em casos ligeiros. Em quadros mais avançados, sonolência, convulsões tipo grande mal e coma. A concentração de eletrólitos no sangue é baixa.

O tratamento consiste na supressão de qualquer ingestão de líquidos, provocar a diurese o mais precocemente possível e corrigir o desequilíbrio eletrolítico.

As convulsões podem controlar-se com diazepam ou outro medicamento análogo.

Em caso de coma, deve assegurar-se a manutenção da função respiratória e aplicar as restantes medidas normais nestes quadros.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 8.1.2 - Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas. Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e antagonistas. Lobo posterior da hipófise, código ATC: H01B B02

Mecanismo de ação

A substância ativa de Oxitocina Generis é um nonapeptídeo sintético. A sua constituição química e as suas propriedades farmacológicas são idênticas às da hormona oitócica natural do lóbulo posterior da hipófise. Atua seletivamente sobre a musculatura lisa do útero especialmente no final da gravidez, durante o parto e no pós-parto, ou seja, quando o número de recetores específicos da oxitocina no miométrio está aumentado.

Efeitos farmacodinâmicos

Quando se administram doses baixas por perfusão intravenosa, a Oxitocina Generis produz contrações uterinas rítmicas que não se distinguem em frequência, intensidade e duração, das observadas num parto espontâneo. Com doses mais elevadas por perfusão intravenosa ou em injeção única, o fármaco é capaz de causar e manter contrações uterinas tetânicas.

Além do seu efeito sobre o útero, a oxitocina produz contrações das células mioepiteliais que rodeiam a glândula mamária, produzindo ejeção do leite e facilitando a lactação.

Uma vez que se obtém por síntese, a Oxitocina Generis encontra-se completamente livre de hormona vasopressora (ausência de vasopressina), no entanto, mesmo na sua forma pura a oxitocina tem uma atividade antidiurética intrínseca mínima, semelhante à da vasopressina.

Outro efeito farmacológico observado com doses elevadas de oxitocina, particularmente quando se administra por injeção em bólus intravenoso rápido, consiste num efeito relaxante direto e transitório sobre a musculatura lisa vascular, tendo como resultado uma ligeira hipotensão, rubor e taquicardia reflexa.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Quando administrado por injeção intravenosa ou intramuscular para prevenção ou tratamento da hemorragia pós-parto, a oxitocina atua rapidamente tendo um período de latência inferior a 1 minuto depois de injeção intravenosa, e de 2 a 4 minutos depois de injeção intramuscular. A resposta oitócica permanece durante 30 a 60 minutos após a administração intramuscular; no caso da injeção intravenosa pode ter menor duração.

Distribuição

Quando a oxitocina é administrada por perfusão intravenosa contínua em doses apropriadas para a indução do parto, a resposta uterina estabelece-se gradualmente, alcançando o estado estacionário normalmente após 20 a 40 minutos. Os níveis plasmáticos correspondentes de oxitocina são comparáveis aos que se observam durante a primeira fase dum parto espontâneo. Após interromper a administração por perfusão ou após uma redução substancial na velocidade de perfusão, p. ex. no caso de sobre-

estimulação, a atividade uterina decresce rapidamente, podendo prosseguir a um nível adequadamente inferior.

Eliminação

A relativa facilidade com que a velocidade e a intensidade das contrações uterinas podem ser reguladas por meio da perfusão intravenosa é devida à curta semivida da oxitocina. Os valores relatados por vários investigadores variam de 3 a 17 minutos. A ligação às proteínas plasmáticas é muito reduzida. A remoção da oxitocina do plasma é efetuada principalmente por via hepática e renal. Menos de 1 % da dose administrada é excretada inalterada pela urina. O volume aparente de distribuição é de aproximadamente 300 ml/kg no homem e a depuração metabólica atinge os 20 ml/kg/min. aprox. no homem e na mulher grávida.

Não é conhecido o grau em que a oxitocina atravessa a barreira placentária ou passa para o leite materno.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade aguda de dose única, genotoxicidade e potencial carcinogénico.

Apenas se observaram efeitos estudo não clínicos a partir de níveis de exposição considerados suficientemente excessivos em relação ao nível máximo de exposição humana, pelo que se revelam pouco pertinentes para a utilização clínica.

Toxicidade Aguda

Os estudos de toxicidade em dose única com oxitocina em ratos e murganhos foram conduzidos através da via oral, intravenosa e subcutânea. A toxicidade aguda oral (e subcutânea) em ratos foi de 20,5 mg/Kg (peso corporal) e excedeu os 514 mg/Kg (peso corporal) em murganhos. Por via intravenosa, a dose letal de oxitocina foi de 2,3 mg/Kg (peso corporal) em ratos e 5,8 mg/Kg (peso corporal) em murganhos. Deste modo, a dose letal de oxitocina por via intravenosa em murganhos foi mais de mil vezes superior à exposição terapêutica humana usual por via intravenosa.

Potencial Mutagénico

Foi publicado um estudo in vitro de genotoxicidade e potencial mutagénico com a oxitocina. Os testes para as aberrações cromossómicas e troca de cromátídeos irmãos em culturas de linfócitos periféricos humanos foram negativos. Não foram detetadas quaisquer alterações significativas no índice mitótico. A oxitocina não apresenta propriedades genotóxicas.

Carcinogenicidade, Teratogenicidade e Toxicidade reprodutiva

O tratamento de ratos com oxitocina em início de gestação, com doses milhares de vezes superiores às doses que induzem o trabalho de parto em humanos, causou morte fetal num estudo, sendo, contudo, a sua relevância desconhecida.

Não estão disponíveis estudos padrão de teratogenicidade, capacidade reprodutiva e carcinogenicidade com a oxitocina.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Cloreto de sódio, ácido acético glacial, acetato de sódio e água para preparações injetáveis.

6.2 Incompatibilidades

A oxitocina é incompatível com soluções contendo metabissulfito de sódio como estabilizador e plasmina 200 mg ou varfarina de sódio 10 mg em 100 ml de glucose injetável.

A oxitocina não deve ser administrada através do mesmo dispositivo que o sangue e o plasma, porque as ligações peptídicas são rapidamente quebradas pela oxitoquinase.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar no frigorífico (2°C a 8°C).

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Ampolas de vidro incolor Tipo I com 1 ml de capacidade.
Embalagens de 10 e 100 ampolas de 1 ml.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Ver secção 4.2.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Generis Farmacêutica, S.A.
Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora
Portugal

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

N.º de registo: 5772488 – 10 ampolas de 1 ml de solução injetável, 10 U.I./1 ml vidro incolor Tipo I

N.º de registo: 5772587 – 100 ampolas de 1 ml de solução injetável, 10 U.I./1 ml vidro incolor Tipo I

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 30 de março 2006

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO